Intimidad *sin dolor*

SALUD ÍNTIMA · PAREJA · DESEO

SIN VERGÜENZA

CON EVIDENCIA



DENTRO

- Qué es y por qué pasa
- Opciones paso a paso
- Guion de pareja
- Plan de 4 semanas
- Cuándo consultar

Tu bienestar íntimo también es salud.

Guía del síndrome genitourinario de la menopausia, el deseo y la conversación de pareja.

COMPLEMENTO DE PAUSA

QUÉ ES

Ponerle nombre a lo que duele

No es «la edad» ni falta de deseo: es un cambio de los tejidos que tiene nombre, es frecuente y se trata.



tiene nombre

27–84%
de las mujeres posmenopáusicas vive el síndrome genitourinario, según los estudios.

1 de 2
mujeres con síntomas, en una encuesta a 1.858, nunca había usado tratamiento.

3 de 4
de ellas, aprox., nunca lo había hablado con un profesional.

Fuente: The Menopause Society, declaración sobre el síndrome genitourinario de la menopausia, 2020.

El **síndrome genitourinario de la menopausia** (SGM) agrupa los cambios en vulva, vagina, uretra y vejiga que aparecen cuando bajan los estrógenos. Antes se llamaba «atrofia vaginal»; el nombre nuevo incluye los síntomas urinarios.

A diferencia de los sofocos, el SGM **en general progresa si no se trata**, y suele volver al suspender el tratamiento. Por eso conviene hablarlo pronto.

El deseo depende de muchas cosas a la vez: dolor, cansancio, ánimo, relación. Si duele, es lógico que el cuerpo lo evite. Tratar el dolor suele ser el primer paso para recuperar las ganas.

Señales frecuentes

- Sequedad, ardor o picor vaginal
- Dolor o molestia en las relaciones
- Poca lubricación con la excitación
- Urgencia o escapes de orina
- Infecciones urinarias repetidas
- Pequeños sangrados tras la relación

The Menopause Society (2020) y OMS (2024). Un sangrado siempre se consulta.

Hablarlo no es exagerar.

Si en la consulta nadie te pregunta por tu salud íntima, pregúntalo tú: **«Tengo dolor en las relaciones y sequedad desde hace meses. Quiero saber qué opciones tengo».**

OPCIONES PARA HABLAR CON TU PROFESIONAL

paso a paso



Lo que existe

No es una receta: es un mapa para que la conversación con tu médica sea concreta. Ella valorará tu historia y tus preferencias.

1 · SIN RECETA

Lubricantes durante la actividad sexual. Alivian la fricción en el momento. Nivel A

Hidratantes vaginales de acción prolongada, de uso regular (habitualmente 2–3 veces por semana), con o sin relaciones. Nivel A

2 · CON RECETA

Estrógeno vaginal a dosis baja, si los síntomas son moderados o intensos o el paso 1 no basta. Puede usarse a cualquier edad y por tiempo prolongado si hace falta. Nivel A

DHEA vaginal u **ospemifeno** oral: otras opciones con receta para síntomas moderados o intensos. Nivel A

Terapia hormonal sistémica: una opción cuando además hay sofocos o sudores nocturnos.

APOYO

Fisioterapia de suelo pélvico: muchas mujeres se benefician, sobre todo si hay dolor o tensión muscular.

Fuentes: The Menopause Society, declaración sobre SGM (2020) y sobre terapia hormonal (2022). «Nivel A»: recomendación basada en evidencia consistente.

Preguntas para llevar

- [ ] ¿Lo que tengo es síndrome genitourinario u otra cosa?
- [ ] ¿Qué opción del paso 1 me recomiendas y cómo la uso?
- [ ] Si no mejora, ¿cuál es el siguiente paso para mí?
- [ ] ¿Me conviene ver a fisioterapia de suelo pélvico?

SI TUVISTE CÁNCER DE MAMA O DE ENDOMETRIO

Empieza por opciones no hormonales. Si no bastan, datos observacionales sugieren que el estrógeno vaginal a dosis baja puede ser seguro en casos seleccionados: decídelo siempre con tu equipo de oncología.

The Menopause Society, 2022.

LA CONVERSACIÓN DE PAREJA

Decirlo en voz alta, juntos

juntos

El silencio se llena de malentendidos: «ya no le gusto», «me rechaza». Nombrar lo que pasa protege a los dos. Elige un momento tranquilo, fuera del dormitorio.

Guion en cinco tiempos

1 · ABRIR
«Quiero hablarte de algo íntimo que me está pasando. Me cuesta, pero prefiero que lo sepas.»

2 · EXPLICAR
«Tengo sequedad y dolor. Tiene nombre y es frecuente en la menopausia. No es falta de cariño hacia ti.»

3 · SENTIR
«A veces evito el contacto porque me da miedo que duela, y luego me siento culpable.»

4 · PEDIR
«Necesito que vayamos sin prisa, que podamos parar cuando lo diga y que busquemos opciones juntos.»

5 · ACORDAR
«¿Probamos un plan de cuatro semanas y lo revisamos al final?»

Adapta las frases a tu voz. Para prepararla, usa la Plantilla 03 «Plan de conversación».

PARA TU PAREJA

Lo que puedes hacer tú

1. Escuchar sin tomártelo como algo personal.
2. Quitar presión: la cercanía no tiene que terminar en relación sexual.
3. Respetar el «para» al instante, sin reproches.
4. Informarte: leer esta guía también es cuidar.
5. Ofrecer acompañarla a la consulta, si ella quiere.
6. Compartir lo práctico: comprar lo necesario, recordar el plan.



Una regla: si duele, se para.

El dolor es una señal del cuerpo, no algo que haya que aguantar por la pareja. Si en tu relación hay presión, miedo o violencia, eso no es un problema de menopausia: busca apoyo en un servicio de tu país o en alguien de confianza.

PLAN EDITABLE

sin prisa



Cuatro semanas para reencontrarse

Sin metas de rendimiento: se trata de recuperar la cercanía y la comodidad, a vuestro ritmo. Marca cada paso cuando lo hagáis.

1 SEMANA UNO
Hablar

- [ ] Tenemos la conversación de la página 04.
- [ ] Acordamos una «pausa sin presión»: cercanía sin expectativa de relación sexual.
- [ ] Elegimos una señal sencilla para decir «hoy no» sin culpa.

2 SEMANA DOS
Cercanía

- [ ] Un rato juntos cada día sin pantallas: un paseo, una comida, una charla.
- [ ] Abrazos y caricias sin meta, solo por estar cerca.
- [ ] Cada uno dice una cosa que le hizo sentir querido.

3 SEMANA TRES
Comodidad

- [ ] Pido cita y llevo las preguntas de la página 03.
- [ ] Empiezo la opción que acordé con mi profesional (p. ej., un hidratante de uso regular).
- [ ] Anoto qué me hace sentir más cómoda y qué no.

4 SEMANA CUATRO
Acordar un ritmo

- [ ] Revisamos juntos el mes: qué ayudó, qué no.
- [ ] Decidimos qué queremos mantener.
- [ ] Si sigue habiendo dolor, vuelvo a consulta: hay más pasos posibles.

Nuestra revisión al final del mes

Lo que más nos ayudó

Lo que cambiaríamos

Nuestro acuerdo para el próximo mes

Próxima cita con mi profesional

Plan orientativo elaborado por el equipo editorial de PAUSA a partir de las opciones de The Menopause Society (2020). No sustituye la valoración de un profesional ni una terapia sexual o de pareja.

CUÁNDO CONSULTAR

Tu bienestar íntimo también es salud



con amigas también

Pide cita si...

- El dolor en las relaciones se repite o empeora.
- Tienes ardor, picor o sequedad que no mejora con lo que ya usas.
- Tienes infecciones urinarias repetidas o escapes de orina.
- Aparece flujo con mal olor, llagas o bultos.
- Tuviste cáncer de mama o de endometrio y quieres revisar opciones con tu equipo de oncología.

SIN ESPERAR

Cualquier sangrado después de 12 meses sin regla, aunque sea leve, de una sola vez o solo manchado.

HSE (Irlanda), «Postmenopausal bleeding».

RECUERDA

Esta guía es educativa. No diagnostica ni sustituye la atención de un profesional. Nunca empieces ni cambies un tratamiento sin indicación médica.

Fuentes

CONSULTADAS EL 26 OCT. 2026

1 The Menopause Society. The 2020 genitourinary syndrome of menopause position statement. *Menopause*, 2020. isswsh.org/images/content/2020-NAMS-GSM-Paper.pdf

2 The Menopause Society. The 2022 hormone therapy position statement. *Menopause*, 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35797481 · Resumen: letstalkmenopause.org

3 Organización Mundial de la Salud. Nota descriptiva «Menopausia», 16 oct. 2024. who.int/news-room/fact-sheets/detail/menopause

4 HSE (Irlanda). Postmenopausal bleeding. www2.hse.ie/conditions/postmenopausal-bleeding

Hablarlo no es exagerar.

Anota tus síntomas íntimos en **menopausia-equilibrada.vercel.app/#hoy** y llévalos a tu cita.